

Desorden de Personalidad



Expositora:
Arelis Quintero

**Psicopatología de la niñez y
adolescencia**

Profesora:
Dra. Aelen López

2 de mayo del 2026



Desorden de Personalidad



Frase:

“La personalidad no define el valor de una persona, pero comprender sus patrones puede cambiar su vida”

CONTENIDO





DESORDEN DE PERSONALIDAD

DEFINICIÓN GENERAL (DSM-5-TR)



Patrón perdurable de experiencia interna y comportamiento.

DEFINICIÓN SEGÚN CIE-11



Se caracteriza por **alteraciones generalizadas en el funcionamiento del sí mismo** (identidad, autoestima, autodirección)...

CONTENIDO



CRITERIO A (PARTE 1)



Patrón perdurable de comportamiento y experiencia interna

Se desvía de las **expectativas culturales**.

Se manifiesta en:



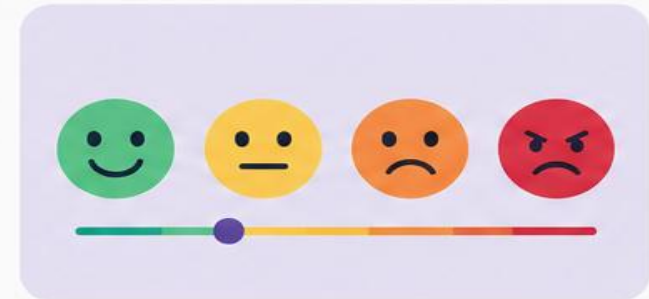
- **Cognición:**

forma de pensar y percibir e interpretarse a uno mismo, a los demás y a los acontecimientos.



- **Afectividad:**

la amplitud, intensidad, labilidad e idoneidad de la respuesta emocional.



CRITERIO A (PARTE 2)



Criterio A: Patrón perdurable de comportamiento y experiencia interna que se desvía de las expectativas culturales.

Se manifiesta también en:



- **Funcionamiento interpersonal:**

Forma en que la persona se relaciona con los demás.



- **Control de los impulsos:**

Capacidad para regular conductas y evitar acciones impulsivas.



CRITERIO B



Inflexibilidad del patrón

El patrón de pensamiento, emociones y conductas es **rígido** y no cambia fácilmente.

Se presenta en múltiples situaciones personales y sociales:



En casa



Con amigos y familiares



En el trabajo o estudio



En distintos contextos sociales



CRITERIO C



Malestar o deterioro significativo

El patrón perdurable causa **malestar** clínicamente significativo o **deterioro** en áreas importantes de la vida de la persona.



Afecta la vida social

Dificulta las relaciones y la interacción con otras personas.



Afecta el trabajo o estudio

Interfiere con el rendimiento laboral, académico y la productividad.



Impacta otras áreas importantes

Compromete el bienestar general y la capacidad para funcionar adecuadamente en diferentes aspectos de la vida.



CRITERIO D



Duración y estabilidad del patrón

El patrón es estable y de larga duración, y su inicio se remonta a la adolescencia o a las primeras etapas de la edad adulta.



- **Estable en el tiempo:**

No es algo pasajero; se mantiene a lo largo de los años.



- **Inicio temprano:**

Generalmente comienza en la adolescencia o en la adultez temprana.



CRITERIO E



No se explica por otro trastorno mental

El patrón perdurable no se explica mejor como una manifestación o consecuencia de otro trastorno mental.



- **Evaluación diferencial:**

Se debe analizar cuidadosamente para no confundirlo con otros trastornos mentales.



- **Diagnóstico preciso:**

El profesional debe determinar que los rasgos de personalidad son el problema principal.



Es importante diferenciarlo de otros trastornos mentales.

CRITERIO F



No es causado por sustancias o enfermedad médica

El patrón perdurable no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia o a otra afección médica.



- **Sustancias:**

No debe ser consecuencia del consumo de drogas, alcohol o medicamentos.



- **Afección médica:**

Tampoco debe explicarse por una enfermedad o lesión cerebral.



- **Valoración clínica:**

Se requiere una evaluación completa para identificar la causa real.



CONTENIDO



‘RESUMEN DE SALUD MENTAL Y TRASTORNOS DE PERSONALIDAD EN LA CAJA DE SEGURO SOCIAL (CSS)’

DATOS CONSOLIDADOS BASADOS EN REPORTES DE GESTIÓN RECIENTES

CUADRO CONSOLIDADO DE ATENCIONES EN SALUD MENTAL (CSS)			
	Categoría de Indicador	Dato Estadístico (Aprox.)	Observaciones Relevantes
1	Consultas anuales totales	171,447	Sumatoria de Psiquiatría, Psicología y Trabajo Social.
2	Atenciones por Psicología	98,893	Representa la mayor carga de seguimiento terapéutico.
3	Atenciones por Psiquiatría	70,212	Enfocado en diagnóstico y manejo farmacológico.
4	Prevalencia en Población	10%	Estimación de panameños con algún trastorno mental.
5	Rango de Edad Crítico	15 - 64 años	Población donde más se detectan desórdenes de personalidad.
6	Abastecimiento de Psicofármacos	92%	Nivel de disponibilidad de medicamentos especializados.

PERFIL DE LOS TRASTORNOS DE PERSONALIDAD Y COMPORTAMIENTO

1. Frecuencia de Diagnóstico

OCUPA EL 4º LUGAR
(dapués de Ansiedad, Depresión, Adaptación)

2. Distribución Geográfica

MAYOR CONCENTRACIÓN
Región Metropolitana y Panamá Oeste
(con un alta población y hospitales de 3º nivel)

3. Detección por Género

MUJERES:
Trastorno Límite de la Personalidad (TLP)

HOMBRES:
Control de Impulsos y Conducta Antisocial

FACTORES DE RIESGO IDENTIFICADOS (TAMIZAJE SRQ-20)

ESTRÉS LABORAL
(Crisis de identidad)

DISFUNCIÓN FAMILIAR
(65% en jóvenes)

VULNERABILIDAD SOCIOECONÓMICA
(FUPS en áreas de difícil acceso)

TÉCNICA DE TAMIZAJE (SRQ-20)



ESTADÍSTICAS

Trastornos de la Personalidad



Tipo de dato	Panamá	Internacional
Prevalencia general	No hay cifras oficiales específicas; se estima similar a América Latina ($\approx$ 6–10%)	Entre 6% y 10% de la población general
En población clínica	Datos limitados; aumento en consultas de salud mental	Hasta 40–60% en pacientes psiquiátricos
Trastorno más común	No reportado oficialmente	Trastorno límite y antisocial entre los más frecuentes
Edad de inicio	Adolescencia o adultez temprana	Adolescencia o adultez temprana
Impacto funcional	Asociado a dificultades sociales y laborales	Alto deterioro interpersonal y social
Sistema de diagnóstico usado	Uso combinado de DSM y CIE en práctica clínica	DSM-5-TR (EE.UU.) y CIE-11 (global)

PREVALENCIA GENERAL EN POBLACIÓN GENERAL



EN POBLACIÓN CLÍNICA (PACIENTES PSIQUIÁTRICOS)



Los trastornos de la personalidad representan un importante desafío para la salud mental a nivel local e internacional, con un impacto significativo en la calidad de vida.



Nota: Las cifras pueden variar según la población estudiada y los criterios diagnósticos utilizados.

CONTENIDO





CUADRO COMPARATIVO

Criterios del Trastorno de la Personalidad: DSM-5-TR vs. CIE-11



Criterio		DSM-5-TR	CIE-11
	Enfoque general	Categorial (trastornos específicos)	Dimensional (niveles de severidad)
	Clasificación	10 trastornos divididos en 3 grupos (A, B, C)	Un solo diagnóstico general con especificadores
	Grupos	Grupo A (raros/excéntricos), B (dramáticos/emocionales), C (ansiosos/temerosos)	No utiliza grupos
	Diagnóstico principal	Se diagnostica un trastorno específico (ej. límite, narcisista)	Se diagnostica “Trastorno de la personalidad” + gravedad
	Gravedad	No se enfatiza tanto	Leve, moderado o grave
	Rasgos de personalidad	Criterios específicos por trastorno	Rasgos dominantes: negatividad, desapego, disocialidad, desinhibición, anankastia
	Flexibilidad diagnóstica	Menos flexible	Más flexible y adaptable
	Modelo alternativo	Incluye modelo dimensional en sección III (menos usado clínicamente)	Totalmente dimensional (base del sistema)
	Facilidad de uso clínico	Más tradicional, ampliamente usado	Más moderno, pero requiere adaptación
	Ejemplo diagnóstico	“Trastorno límite de la personalidad”	“Trastorno de la personalidad moderado con rasgos de desinhibición”

CONTENIDO





FAMOSO CON TRASTORNO LÍMITE DE LA PERSONALIDAD



EJEMPLO:

Pete Davidson

Comediante estadounidense



TRASTORNO:

Trastorno Límite de la Personalidad (TLP)

Es un patrón de inestabilidad en las emociones, las relaciones y la imagen de sí mismo.



¿QUÉ HA COMPARTIDO?

- Ha hablado públicamente sobre su diagnóstico.
- Ha mencionado dificultades emocionales y relaciones intensas.



CARACTERÍSTICAS OBSERVADAS:

- Cambios emocionales intensos.
- Impulsividad.
- Sensibilidad al abandono.
- Relaciones inestables.



IMPORTANCIA:

Su caso ayuda a:

- Visibilizar el trastorno.
- Reducir el estigma.
- Promover la salud mental.



TRATAMIENTO:

- Terapia psicológica (ej. TCC, DBT).
- Apoyo emocional y familiar.
- Manejo profesional continuo.



MENSAJE FINAL

Peter Davidson ha usado su experiencia para generar conciencia sobre la salud mental.
Hablar del trastorno no es debilidad, es el primer paso para sanar.





BRANDON MARSHALL

Y EL TRASTORNO LÍMITE DE LA PERSONALIDAD (TLP)



¿QUIÉN ES?

Brandon Marshall es un exjugador profesional de fútbol americano (NFL) y personalidad de medios estadounidense.



¿QUÉ HA COMPARTIDO?

Brandon Marshall ha hablado abiertamente sobre su diagnóstico de Trastorno Límite de la Personalidad (TLP) y cómo ha afectado su vida, sus relaciones y su carrera.



CARACTERÍSTICAS QUE HA MENCIONADO

- Cambios emocionales intensos.
- Miedo al abandono.
- Relaciones inestables y conflictivas.
- Impulsividad y dificultad para controlar la ira.
- Sensación de vacío y baja autoestima.



IMPACTO EN SU VIDA

- Ha enfrentado dificultades en sus relaciones personales y profesionales.
- Tuvo problemas con el manejo de la ira que lo llevaron a suspensiones en la NFL.
- Reconoce que entender su diagnóstico fue clave para comenzar su proceso de sanación.



DIAGNÓSTICO

- Fue diagnosticado por profesionales de la salud mental.
- Se basa en criterios clínicos del DSM-5-TR o la CIE-11.
- No es un diagnóstico de “debilidad”, sino una condición tratable.



TRATAMIENTO Y MANEJO

- Brandon ha seguido terapia (especialmente Terapia Dialéctico Conductual – TDC/DBT).
- También se apoya en su fe, meditación y hábitos saludables.
- La constancia en el tratamiento le ha permitido tener una vida más estable y plena.



¿POR QUÉ SU HISTORIA ES IMPORTANTE?

- Ayuda a visibilizar el TLP.
- Rompe estigmas sobre la salud mental.
- Inspira a otras personas a buscar ayuda y no rendirse.



MENSAJE CLAVE

Brandon Marshall demuestra que, con diagnóstico, tratamiento y apoyo, es posible entender el TLP, manejar los síntomas y construir una vida significativa.



“Mi diagnóstico no me define, pero entenderlo me dio libertad.”
– Brandon Marshall



AMBER HEARD Y EL TRASTORNO LÍMITE DE LA PERSONALIDAD (TLP)



¿QUIÉN ES?

Amber Heard es una actriz estadounidense, conocida por películas como Aquaman y por su participación en diversos juicios mediáticos.



¿QUÉ TRASTORNO TIENE?

Amber Heard ha mencionado públicamente que fue diagnosticada con Trastorno Límite de la Personalidad (TLP). Ella lo compartió para explicar parte de sus dificultades emocionales.



CARACTERÍSTICAS DEL TLP

- Inestabilidad emocional intensa.
- Relaciones interpersonales intensas e inestables.
- Miedo al abandono.
- Impulsividad.
- Cambios frecuentes en la autoimagen.



¿QUÉ HA EXPRESADO AMBER HEARD?

- Ha hablado sobre sus luchas emocionales desde joven.
- Mencionó que el diagnóstico la ayudó a comprenderse mejor.
- Pidió empatía y comprensión hacia las personas que viven con este trastorno.



DIAGNÓSTICO

- El TLP solo puede ser diagnosticado por un profesional de la salud mental.
- Se basa en criterios clínicos del DSM-5-TR o la CIE-11.



TRATAMIENTO

- Psicoterapia (especialmente TCC y DBT).
- Medicación para tratar síntomas asociados (ansiedad, depresión, etc.).
- Apoyo emocional y red de contención.



IMPORTANCIA DE SU TESTIMONIO

Su caso ha generado conversación mundial sobre salud mental, ayudando a visibilizar el Trastorno Límite de la Personalidad y a reducir el estigma que aún existe alrededor de los trastornos mentales.



CONTENIDO





Impacto en la salud mental de familiares con pacientes con trastorno límite de personalidad (TLP)



PAÍS Y AÑO

Ecuador (Quito), 2025



AUTORA

Ámbar Doménica Meza Álava



TIPO DE INVESTIGACIÓN

Cuantitativa, de alcance explicativo



HIPÓTESIS

La convivencia con un paciente con Trastorno Límite de la Personalidad (TLP) aumenta el riesgo de ansiedad, depresión y estrés en los familiares.



MUESTRA

270 participantes (familiares), seleccionados mediante muestreo no probabilístico (deliberado/crítico).

VARIABLES



INDEPENDIENTES

- Convivencia con paciente con TLP
- Temperamento lábil del paciente



DEPENDIENTES

- Niveles de estrés
- Niveles de depresión
- Niveles de ansiedad

INSTRUMENTOS



Inventario Clínico Multiaxial de Millon IV (MCMI-IV)



Escala de Estrés Percibido



Inventario de Depresión de Beck



Cuestionario de Ansiedad Estado-Rasgo

RESULTADOS ESPERADOS



Alteraciones en los niveles de estrés, ansiedad y depresión.



Mayor afectación en las figuras maternas (niveles más altos).



El temperamento lábil influye en dichas alteraciones.

CONTENIDO



MINUTES

Preguntas Y Comentarios

REFERENCIAS

<https://prensa.css.gob.pa/2024/10/10/css-atiende-171-mil-447-citas-de-salud-mental-en-ocho-meses>

<https://www.msmanuals.com/es/professional/trastornos-psiqui%C3%A1tricos/trastornos-de-la-personalidad/generalidades-sobre-los-trastornos-de-la-personalidad>

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC281691>

<https://prensa.css.gob.pa/2024/10/22/trastornos-mentales-siguen-aumentando-en-panama-despues-de-pandemia>

<https://dspace.udla.edu.ec/handle/33000/17975>



GRACIAS

